

AAMIA · RESUMEN TEMÁTICO 3 DE 5

Alimentación, hidratación y salud digestiva

Nutrición adaptable, seguridad al comer, salud bucal y prevención del estreñimiento

alimentación

hidratación

desnutrición

Audiencia: Personas mayores, familias y cuidadores

Uso responsable

Este documento organiza y resume una biblioteca local. No diagnostica, no prescribe y no sustituye una valoración profesional. Las fuentes originales son la evidencia canónica; las referencias usan la página física del PDF.

Edición 1.0 · Julio de 2026 · Proyecto AAMIA

Cómo usar este resumen

Está diseñado para recuperación aumentada: cada apartado concentra una intención de búsqueda y conserva referencias legibles. Para decisiones importantes se consulta la fuente original y al equipo profesional.

Campo	Valor
Tema principal	Alimentación, hidratación y salud digestiva
Temas de recuperación	alimentación, hidratación, desnutrición, disfagia, hipertensión, estreñimiento, fecaloma, salud bucal
Tipo de fuente	Resumen secundario; remite a evidencia original
Riesgo clínico	Mixto: educativo con señales de consulta y urgencia
Contexto Markdown	Usado para redactar; no es documento indexado

Principios de síntesis

- La alimentación debe ser suficiente, variada, agradable y compatible con la situación clínica y cultural.
- Cambios de peso, apetito, deglución o hidratación son datos de salud.
- No existe un menú universal para todas las personas mayores.
- Restricciones de sal, líquidos, textura o nutrientes deben individualizarse.

Jerarquía de uso

- 1) localizar el tema; 2) recuperar los fragmentos originales; 3) responder indicando documento y página; 4) reconocer cuando la biblioteca no basta.

1. Una base flexible y apetecible

La meta es combinar adecuación, equilibrio, moderación y diversidad sin convertir la comida en una imposición.

- Incluir verduras y frutas, cereales o tubérculos, leguminosas y fuentes apropiadas de proteína.
- Preferir alimentos poco procesados y adaptar porción, textura, temperatura y presentación.
- Respetar preferencias, cultura, horarios y posibilidades económicas; comer acompañado puede ayudar.
- Considerar diagnósticos, actividad, dentición, apetito y capacidad para comprar o cocinar.

Síntesis de [R1, p. 4], [R2, pp. 30 y 34-36], [R3, pp. 4-6] y [R4, p. 4].

2. Detectar riesgo nutricional

La pérdida de peso involuntaria, menor fuerza o cambios sostenidos de apetito no deben asumirse como inevitables.

- Observar peso, ajuste de ropa, fuerza, número de comidas, proteína, frutas, verduras y líquidos.
- Investigar dolor dental, prótesis, boca seca, deglución, depresión, aislamiento, medicamentos o acceso a alimentos.
- Consultar ante pérdida de peso, debilidad creciente, heridas que no cicatrizan, edema, vómitos o rechazo persistente.
- La evaluación profesional integra historia, peso, función, enfermedades y alimentación; una cifra aislada no basta.

Riesgo y evaluación en [R3, pp. 4-5], [R4, p. 12] y [R9, p. 21].

3. Hidratación individualizada

La sensación de sed puede disminuir y algunas personas necesitan recordatorios, pero otras tienen restricciones médicas.

- Ofrecer líquidos regularmente en cantidades manejables si no existe restricción indicada.
- Usar vasos fáciles de sujetar y dejar agua visible; registrar ingesta cuando haya riesgo.
- Observar boca seca, orina escasa u oscura, mareo, debilidad, somnolencia o confusión nueva.
- En enfermedad renal, cardíaca o hepática, seguir la cantidad indicada por el equipo tratante.

Hidratación en [R1, p. 4], [R3, p. 5] y [R4, pp. 12 y 19].

4. Comer y beber con seguridad

Tos, voz húmeda, atragantamiento, alimento retenido o infecciones respiratorias repetidas pueden sugerir dificultad de deglución.

- Procurar postura sentada y estable; no alimentar a una persona somnolienta o acostada.
- Ofrecer tiempo, porciones pequeñas y un ambiente sin prisas.
- No cambiar consistencias, usar espesantes ni triturar medicamentos sin indicación individual.
- Ante obstrucción completa o incapacidad para respirar, activar emergencias y aplicar solo maniobras con capacitación vigente.

Seguridad general en [R1, p. 4] y [R7, pp. 47 y 49].

5. Hipertensión y sodio

Reducir sodio suele formar parte del manejo, pero la intensidad de la restricción debe ajustarse a cada persona.

- Priorizar alimentos frescos y revisar etiquetas de procesados, embutidos, sopas, salsas y botanas.
- Dar sabor con hierbas y especias compatibles con preferencias y tolerancia.
- No usar sustitutos con potasio sin consultar; pueden ser inadecuados en enfermedad renal o con ciertos fármacos.
- No trasladar cantidades exactas de fuentes antiguas sin confirmación profesional actual.

Principios revisados en [R2, pp. 14, 34-36 y 40-44].

6. Estreñimiento y fecaloma

El estreñimiento puede relacionarse con fibra, líquidos, inactividad, rutina, medicamentos o enfermedades.

- Registrar frecuencia, consistencia, esfuerzo, dolor, evacuación incompleta y cambios del patrón habitual.
- Aumentar fibra gradualmente con líquidos permitidos; mantener movimiento, privacidad y tiempo.
- No iniciar laxantes, enemas o extracción manual sin orientación, sobre todo con dolor o distensión.
- Diarrea líquida inesperada con estreñimiento crónico puede coexistir con retención fecal y requiere valoración.

Prevención en [R4, p. 12] y [R5, p. 25]; retención en [R6, pp. 1-2] y [R7, pp. 171-174].

7. Salud bucal y experiencia de comer

Dolor, pérdida dental, prótesis floja, boca seca o lesiones pueden reducir variedad y cantidad de alimentos.

- Realizar higiene bucal y de prótesis regularmente y con respeto.
- Observar úlceras, sangrado, placas, dolor, olor persistente y cambios para masticar.
- Solicitar atención dental ante prótesis que lastima, lesión persistente o dificultad para alimentarse.
- Adaptar preparaciones sin eliminar grupos de alimentos ni reducir innecesariamente el placer de comer.

Boca y nutrición en [R2, p. 85], [R4, pp. 4 y 12] y [R8, p. 128].

Orientación por nivel de acción

Esta tabla no es un sistema de triaje. Resume una respuesta conservadora a cambios comunes y señales de peligro.

Nivel	Situación	Acción
Ajustar	Apetito variable sin pérdida de peso ni dificultad.	Ofrecer porciones manejables, variedad y registrar preferencias.
Consultar	Pérdida de peso, tos al comer, rechazo persistente, estreñimiento nuevo, dolor o deshidratación.	Solicitar valoración médica, nutricional, dental o de deglución.
Atención urgente	Atragantamiento sin poder respirar, pérdida de conciencia, sangre en vómito, sangrado importante, dolor abdominal intenso o deterioro rápido.	Contactar emergencias locales.

Regla de seguridad

Cuando el cambio es súbito, intenso, empeora rápido o la persona no puede mantenerse a salvo, se prioriza ayuda humana inmediata sobre la consulta al RAG.

Qué debe conservar una respuesta de AAMIA

- Diferenciar educación general de indicaciones personalizadas.
- Mostrar fuentes originales y páginas que sostienen la respuesta.
- Declarar incertidumbre, antigüedad o desacuerdo entre fuentes.
- No transformar procedimientos clínicos en instrucciones domésticas.
- Recordar que autonomía, preferencias y contexto importan.

Fuentes utilizadas

Las páginas son páginas físicas del PDF. Las referencias documentan conceptos centrales; no implican adoptar toda afirmación de la fuente.

Criterio editorial

Se priorizaron recomendaciones convergentes, prudentes y aplicables. Las fuentes antiguas o especializadas se conservaron como contexto cuando requerían corroboración actual.

[R1] AAMIA_guia_abierta_para_el_cuidado.pdf

Páginas PDF: 4. Tipo: Guía abierta.

[R2] Guía didáctica alimentación saludable para adultos mayores hipertensos (Instituto Superior Tecnológico American College).pdf

Páginas PDF: 14, 30, 34-36, 40-44. Tipo: Guía didáctica.

[R3] La nutrición en el adulto mayor - una oportunidad para el cuidado de enfermería.pdf

Páginas PDF: 4-6. Tipo: Revisión de enfermería.

[R4] Nutricion y Cuidados del Adulto Mayor. Estudio Monografico (vmoya).pdf

Páginas PDF: 4, 12, 19, 26. Tipo: Estudio monográfico.

[R5] Gastronomía como estrategia para el manejo del estreñimiento en el adulto mayor (Valencia Naranjo, Alejandra & Muñoz Contreras, Angélica María & Cardona Gallo, David).pdf

Páginas PDF: 25. Tipo: Trabajo académico.

[R6] Caso-cl-nico-radiol-gico-fecaloma---importante-complic_2012_Revista-M-dica-C.pdf

Páginas PDF: 1-2. Tipo: Caso clínico, 2012.

[R7] Cuidado de los adultos mayores (Lesur, Luis).pdf

Páginas PDF: 47, 49, 171-174. Tipo: Libro de consulta.

[R8] MANUAL_BASICO_CUIDADO_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_16_JULIO_221021.pdf

Páginas PDF: 85, 124, 128. Tipo: Manual institucional.

[R9] Manual_cuidados-generales.pdf

Páginas PDF: 21. Tipo: Manual práctico.

Contexto editorial no indexado

Estos Markdown ayudaron a contrastar lenguaje y necesidades domésticas. No se incorporan al índice ni a la carga pública.

- Articulo web- Cuidado de adultos mayores en casa- Una guía integral.md (comidas y apoyo domiciliario; no indexado).
- Articulo web- Qué cuidados debo brindar a un adulto mayor.md (alimentación general; no indexado).